Markeren van afwijking in borst en/of lymfeklier in de oksel met een (hydro)marker (mammalokalisatie)

Met u is besproken dat een 'lokalisatie' nodig is. Hierbij wordt de exacte plaats van de afwijking in uw borst en/of lymfeklier gemarkeerd door middel van een (hydro)marker.

De lokalisatie met de (hydro)marker is nodig, omdat u wordt behandeld met chemotherapie voordat u wordt geopereerd. Door de chemotherapie kan de afwijking (gebied) dusdanig geslonken zijn, dat het niet meer voelbaar/zichtbaar is met behulp van echografie of mammografie. Het is dan belangrijk om bij de start van de behandeling een (hydro)marker te plaatsen. Deze blijft zowel op echografie als op het mammogram zichtbaar. Het doel van het markeren is dat, na uw behandeling met chemotherapie, de afwijking (gebied) kan worden herkend om een ‘magneetzaadje’ ernaast te plaatsen. Het magneetzaadje is nodig om de afwijking (gebied) terug te vinden tijdens de operatie.

Voor de operatie van de borst wordt er een magneetzaadje geplaatst naast de (hydro)marker. Door het magneetzaadje kan tijdens de operatie de plaats van de afwijking met speciale apparatuur zichtbaar gemaakt worden. De chirurg weet zo exact waar de afwijking zich bevindt.

Meer informatie over het magneetzaadje vindt u in de folder: Mammalokalisatie door middel van magneetzaadje.

Het plaatsen van de (hydro)marker

Voorbereiding:

- Voor dit onderzoek mag u geen bodylotion, crème, zinkzalf of talkpoeder gebruiken op uw borsten.
- Draag losse, comfortabele kleding en een stevige bh voor steun na het onderzoek.
- Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, meldt dit dan op de afdeling Radiologie.

Onderzoek

U meldt zich op de afgesproken tijd bij de receptie of aanmeldzuil van de afdeling Radiologie. De laborante roept u naar binnen als u aan de beurt bent en vraagt u uw bovenkleding uit te doen. De radioloog voert het onderzoek uit, samen met één of twee specialistische laboranten.

Er zijn twee mogelijkheden om de tumor goed in beeld te brengen tijdens het plaatsen van de (hydro)marker. Meestal kan dit met behulp van echografie (geluidsgolven) en anders met behulp van een mammografie (röntgenstralen).

- Echografie: Als bij u de afwijking waarneembaar is met behulp van echografie, wordt u gevraagd op uw rug te gaan liggen. De radioloog brengt wat gel aan op de borst en bepaalt met de echokop de plaats van de afwijking en de positie voor de naald.
- Mammografie: als bij u de tumor alleen met röntgen waarneembaar is, wordt u gevraagd om op een stoel plaats te nemen met de borst op een steunplaat. De borst wordt platgedrukt door middel van een plaatje, dat de borst gedurende het onderzoek op zijn plaats houdt. De laborant maakt foto's van de borst. Vervolgens kan de radioloog via de computer de plaats van de afwijking en positie voor de naald exact bepalen.

Nadat de exacte plaats van de afwijking en de positie voor de naald zijn bepaald, wordt de (hydro)marker met behulp van een naald in de borst gebracht. Soms worden meerdere (hydro)markers ingebracht.

Tenslotte worden enkele controle foto's gemaakt met het mammografie apparaat om te beoordelen of de (hydro)marker goed is geplaatst. De procedure duurt ongeveer 45 minuten en vindt poliklinisch plaats. Dat wil zeggen dat u na de procedure naar huis kunt.

Risico's en complicaties

Ondanks dat de insteekplaats verdoofd wordt, kan het onderzoek toch pijnlijk zijn. Wij raden u aan om na het onderzoek de arm en borst te ontzien. Ook kunt u paracetamol innemen als u dat nodig vindt.

Het is mogelijk dat na de mammalokalisatie een bloeduitstorting of een infectie optreedt op de plaats waar de (hydro)marker is ingebracht. Het is daarom belangrijk bij toenemende roodheid of zwelling van de borst of oksel, als u koorts krijgt of bij hevige pijnklachten, contact op te nemen met uw behandelend specialist of de mammacare-verpleegkundige.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur.

HagaZiekenhuis Den Haag: (070) 210 2349
HagaZiekenhuis Zoetermeer: (079) 346 2520

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

570112092025